

Registro de ruta clínica local de esguince lateral de tobillo

Formato independiente de registro | Documento asociado: 05-G46

1. Finalidad y momento de uso

Utilizar para registrar registro de ruta clínica local de esguince lateral de tobillo. Revisar el documento asociado antes de diligenciar y registrar la ejecución del proceso correspondiente, no su programación como si ya se hubiera realizado. El formato se entrega vacío; no valida por sí solo cumplimiento de habilitación.

2. Instrucciones por campo

Campo	Cómo diligenciar
Paciente y fecha	Consignar la fecha y hora reales o el periodo completo; no anticipar ejecución ni reconstruir hechos sin identificación de la fuente.
Hipótesis y alcance	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Alarmas y conducta	Describir hechos y consecuencia, control inmediato y necesidad de suspender, derivar o reportar; evitar culpar sin análisis.
Medida inicial y método	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Objetivos	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Intervenciones y fundamento	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Dosis y respuesta	Registrar el dato real, unidad y fuente de aceptación. Usar etiqueta, fabricante o criterio clínico, sin valores universales inventados.
Reevaluación	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Egreso o remisión	Diligenciar el hecho o dato correspondiente al episodio y conservar su fuente; usar no aplica solo con fundamento específico.
Fuente adoptada y autor	Identificar a la persona que realmente intervino y su rol; el espacio se entrega vacío y se completa al ejecutar.

3. Control del registro

Completar datos observados, unidades y soportes. No dejar blancos ambiguos en el registro utilizado: escribir no aplica con razón cuando corresponde. Corregir con anotación trazable, preservando original, fecha y autor; no borrar ni rellenar retrospectivamente. Los campos de identidad y decisión se conservan bajo acceso autorizado.

Registro principal

Fecha y lugar de ejecución: _____
Referencia de episodio, equipo o lote: _____

Paciente y fecha	
Hipótesis y alcance	
Alarmas y conducta	
Medida inicial y método	
Objetivos	
Intervenciones y fundamento	
Dosis y respuesta	
Reevaluación	
Egreso o remisión	
Fuente adoptada y autor	

Vincular los soportes auténticos al archivo correspondiente. Los nombres se completan solo al ejecutar; el encabezado permanece libre para personalización. No hay firmas ficticias ni aprobación preestablecida.

Continuación, novedades y comprobación

Repetir para los hechos que requieren continuidad o una segunda observación. Mantener referencia al registro principal; no usar esta página para ocultar cambios del original.

Fecha y referencia	Dato / actividad observada	Resultado / soporte

Novedad, acción y seguimiento

Novedad y riesgo observado	
Acción inmediata y responsable	
Medida preventiva, plazo y soporte	
Verificación de resultado y eficacia	
Autor o ejecutor y referencia de autenticación	

Reserva y autenticación

La ausencia de casillas de firma no elimina firma o autenticación exigibles, en particular de historia y consentimiento. Incorporar el soporte válido antes del uso asistencial. No aplicar una decisión clínica con un formato de aceptación incompleto. Referencia: 05-G46; criterios 11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

Aprobó
Eliana Milena Pardo Ríos
TP 60576